



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هبه سيد عبدالصبور سيد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : المعصره
رقم البطاقة : 28103162101802 رقم التليفون : 01124196163
العمر (تاريخ الميلاد) : 16-03-1981 المهنة : ربه منزل
العنوان : -----
تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغه [11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: هبة سيد عبد الصبور سيد
National ID: 28103162101802



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين





رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2024-6-23

جهة الاصدار: فرع القاهرة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

المسيد (ة) هبة سيد عبد الصبور بطاقة رقم 28103162101802
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية بليد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اي مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2024-6-23

الموظف المختص

اسلام عبد الحميد

إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد

د/ رانيا مصطفى كمال

مسائل 1367245



الخطاب مازى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة الحكومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Name: هبه سيد عبدالصبور سيد			
MR. : 500			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الخروج :		تاريخ وساعة الدخول :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
2/2025 MDT:PORTH,ZOLADEX +AI,ZOMETA/6M 12/1/2026 ZOLADEX+FEMARA			
PREM RT BREAST CANCER CT4 NO MO ER8/8 PR8/8 HER2-VE REC NACT AC TAXANES ON 12/2024 RT BCS YPT3 N0/2 REC PORT ST ZOLADEX FEMARA FROM 3/2025 ZOLADEX AND ZOMETA DUE DATE 6/ 4 SM12/2025 FREE FOR FEMARA			
today for femara , supp ttt for 3 mn pt complained of severe bony aches bone scan>> R last assessment 11-2025 >> free for new CT CAP , BSM next 10-2026			
تحريرا في ,			
		التاريخ : 19-09-2026	
الوقت :		نهي سعيد علي محمد	
		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

Patient Name	: الأمانة / هبة سيد عبد الصبور سيد	Request No.	: 13001187
Patient No.	: 1961-2024	Request Date	: 04/01/2025
Path No.	: 40/25	Verification Date	: 11/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer post NACT.

Nature of the specimen:

Right wide local excision and sentinel lymph node biopsy specimens, collected at 4/1/2025.

Gross Examination:

Two specimens were received :

- Sentinel lymph node biopsy specimen : Fibrofatty tissue piece measured 3x3 cm , enclosing two nodules measured 1.4x0.8x0.6 cm and 1.5x0.7x0.7 cm.
- Right wide local excision specimen measured 10x7x3 cm with covering skin ellipse measured 5x3 cm.
- Tumor extent
 - o Number: An ill defined rubbery to firm greyish white tumor bed site (wired and clipped) .
 - o Size: 8x2x2cm.
 - o Skin Involvement: Free grossly.
 - Distance from margins: 0.5 cm from deep margin, 0.8 cm from medial margin, 3.5 cm from lateral margin, 2.5 cm from superior margin, 4 cm from inferior margin and 1 cm from superficial margin (not covered by skin).
- Frozen section:
- Free lymph nodes : (0/2).
- Free margins.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(2+2+2).
- Tumor cellularity: 50%.
- Maximal tumor dimension: 6 cm.

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 16/01/2025 12:54:25

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - MIsr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأمينة / هبة محمد عبدالمجيد	Request No. : 13001187
Patient No. : 1961-2024	Request Date : 04/01/2025
Path No. : 40/25	Verification Date : 11/01/2025
Sex : Female	Financial Category : فئة الدولة - ارقام دار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Angiolinvasion: Not detected.
- Ductal carcinoma in situ: Focal, solid and cribriform , intermediate grade (5%).
- Lymph node involvement: Free (0/2).
- Resection Margins: Free all resected margins.
- Histological response to therapy: Pathologic partial response.

Diagnosis:

Right breast cancer post NACT, wide local excision and sentinel lymph node biopsy specimens:

- Invasive duct carcinoma , grade II.
- Tumor cellularity: 50%.
- Free all resected margins.
- Free lymph nodes : (0/2).
- Pathologic partial response.
- Stage : ypT3, N0.
- RCB: 2.129, class: II.

Prof. Gamal Abdelatty
Dr. Rofayda Abdallah

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 16/01/2025 12:54:25

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mısır El Qadima - Cairo, Egypt



Presidential Program for Chronic Disease
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي للأمراض المزمنة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : فية سيدة محمد العاصمير سيدة

Sex:

2- Medical number:

Female

83214189

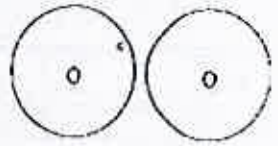
Old Med :

Old Med :

1961-2024

2-ID number:

Patient Age: 44 Y



Family history	Family history	Phone	01124196163	BMI	24.1	REASON OF MDT	REASON OF MDT
marital status	Marital status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT
Co morbidity	Co morbidity	Menopausal status	Menopausal status	Initial STAGE	Initial STAGE	03/02/2025	

Clinical data

Breast Imaging : rt breast 2 speculated solid lesion at 1-12 oclock away from nipple 4 cm measuring 2 x1 cm & 1.8 x1 cm one suspicious axillary LN focal cortical thickening 5 mm			Mets Workup : ct cap:free		
BX IDC No comment	ER 8/8 No comment	PR 8/8 No comment	Her 2 Neu 0 No comment	SISH No comment	KI67 15
T 4A		N 0		M 0	

Sonomammography

PATIENT HISTORY

pt received 4 taxotere --> 4 AC last 18/12/2024 with sluggish response clinically
WLE+SLNB: IDC GII YPT3(6CM)
free margin , 0/2

MDT OUTCOME & PLAN

PORT
ZOLADEX AI
ZOMETA/6MONTHS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition



To whom it may concern

Mrs. / Mr السيدة / السيد 43 years old

female/ male patient presented with diagnosis

... Right Breast Cancer (I.D. & G II)

She/ He was referred to us for (radical / adjuvant / Neoadjuvant /
palliative) Radiotherapy

She / He has received (3D/ IMRT) radiotherapy to.....

..... Right Breast + Parasternal LNs

At Dose : 42 Gy/ 15 fx/ 3 ...w.

Additional (Boost) ; yes/ no. at dose . 6 Gy/ 5 ..fx/ . 1w
(sequential / concomitant)

Started: 11. / 6. / 2025

Ended: 12 / 7. / 2025 With good tolerance .

Head of department
Dr. Hany William



Name: Heba Said Abdel Sabour

Date: 19/12/2024

CLINICAL SUMMARY: Contrast enhanced Spectral Mammography
known case of right breast cancer under therapy

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS: After reviewing previous report dated 09-09-2024, the current study shows:

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: b (scattered fibro-glandular densities)

RIGHT BREAST:

- Low energy (Non contrast) images: upper central deeply seated dense spiculated mass, seen inseparable from anterior linear asymmetry with overlying pleomorphic /coarse microcalcifications, A clip is seen at the anterior margins of linear asymmetry.
- Recombined (Post contrast) images:
 1. Near total resolution of previously reported central mass with clip in situ.
 2. Upper central deeply seated mild/moderate heterogeneously enhancing mass lesion located 7cm from the nipple measures 1.6x1.2cm compared to 2.5x2.4cm in previous report, the deeply seated lesion seen inseparable from anterior faint linear non mass enhancement with clip seen at it anterior part measures 3.8x0.7 cm.
 3. The overall coverage area of the formentioned process 6x2.5cm located 3.5cm from nipple based on MLO view(this area correspond roughly to distribution of the microcalcifications)
- Normal skin / nipple / areolar complex.

LEFT BREAST:

- Low energy (Non contrast) images No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- Recombined (Post contrast) images show, no pathological uptake.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

IMPRESSION:

RIGHT BREAST: (BIRADS6 = pathologically proved malignancy) status follow up after NACT shows partial radiological response as described

LEFT BREAST: (BIRADS 1= Normal)

Best regards,

Dr. Marwa Ramzy, FRCR



Date : 04/07/2024	Patient Name: Heba Sayed Abd Al Sabour
Age : 43 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Pat. ID: 65044	Medical ID: 1961/2024

Name: heba sayed

Date: 4 July 2024

**ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION
REVEALED:**

Liver: -

- Mildly enlarged in size (about 17 cm at the right MCL), smooth outline, normal echopattern.
No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size & , normal wall thickness, large stone (18) seen inside CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size (About 10 cm), displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size , site , well differentiated & with no gross stones or backpressure changes , no solid or cystic lesion.
- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
- No ascites .

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus: is average size , normal endometrial line , no focal lesion.

No adnexal mass or cyst.

Opinion:

Bright hepatomegaly.

Calcular GB.

Signature Dr. Doaa Abdelaziz
04/07/2024 3:27 PM



Women's Health Outreach Program

Name: Heba Saied Abde sabour

Date: 24/6/2024

HIGH RESOLUTION ULTRASOUND OF LEFT BREAST

Clinical summary: 43 years old, right breast pathologically proven IDC GII, for reassessment of the left breast

Technique

High resolution ultrasound

Detailed Findings

After revising the mammography study done on 19.5.2024 in our pacs system, the current examination revealed:

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR b)
- No dominant masses, spiculations, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- No sonographic cystic or solid masses.
- No suspicious lesions
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary lymph nodes detected.

Impression:

Left breast: (BIRADS 1) Normal Study

Best regards,
Dr. Eman Ali

Patient Name	: الأستاذ / هبة محمد عبدالمجيد	Request No.	: 13009739
Patient No.	: 28103162101802	Request Date	: 20/05/2024
Path No.	: 1662/24	Verification Date	: 09/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: وزارة دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Mrs. Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast spiculated mass with foci of microcalcification
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 20/5/2024

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultraview HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) and Ki67 clone (30-9).

Results:

- IPT (Positive control showed appropriate reactivity).
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90 % tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 15% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Right breast cancer, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II

PT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 15% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 11/06/2024 09:42:33

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed youss

CAP
COLLECTION

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - مخبر تشخيص الثدي - مبني القديسة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mhar El Qadima - Cairo, Egypt